FONDAZIONE BOSCACCI

COLLANA EDITORIALE

WHITE PAPER · 2026

Farmaci e malattie rare in Italia

Dall'innovazione all'accesso effettivo alle cure

DIAGNOSI · TERAPIE · ACCESSO · PROPOSTE

Quadro documentale aggiornato al 7 ottobre 2026



Fondazione Boscacci ETS
2026

WHITE PAPER · OTTOBRE 2026

Indice

Sintesi per i decisori 3
Le decisioni proposte 4
01 Ambito e metodo 5
02 Rarità e bisogno terapeutico 5
03 La fotografia italiana 6
04 Il percorso dall'innovazione al paziente 7
05 Diagnosi e screening 8
06 Genomica e pazienti senza diagnosi 8
07 Valutazione AIFA e tempi di accesso 9
08 Regioni e capacità dei centri 10
09 Accesso anticipato e fuori indicazione 10
10 Casi aziendali e criteri di lettura 11
11 Vertex e la fibrosi cistica 12
12 Novartis e la terapia genica nella SMA 12
13 Alexion e l'ipofosfatasia 13
14 PTC Therapeutics e il caso Translarna 14
15 Sostenibilità e valore delle cure 15
16 Ricerca e produzione delle evidenze 15
16A Coordinamento europeo e disponibilità delle forniture 16
17 Ministero AIFA e organismi di coordinamento 17
18 Stato di attuazione e nota di trasparenza 17
19 Continuità assistenziale e famiglie 18
20 Dati e misurazione dei risultati 19
21 Un programma nazionale per l'accesso effettivo 20
22 Priorità risorse e responsabilità 20
23 Roadmap proposta per dodici mesi 21
24 Indicatori e criteri di successo 22
25 Matrice delle criticità e delle soluzioni 22
Fonti e riferimenti 24

Sintesi per i decisori

L'Italia dispone di competenze cliniche, strumenti di accesso e una cornice normativa che consentono di affrontare le malattie rare con una capacità significativa. La priorità di politica sanitaria è trasformare questa capacità in percorsi verificabili: riconoscere il paziente, formulare una diagnosi utilizzabile, valutare il trattamento, renderlo disponibile e assicurare la continuità assistenziale. Una terapia autorizzata o rimborsata è un passaggio necessario; il risultato da misurare è il beneficio effettivamente raggiunto dalle persone eleggibili.

Il quadro richiede una lettura equilibrata. MonitoRare 2026 indica che al 31 dicembre 2024 erano disponibili in Italia 140 dei 147 farmaci orfani autorizzati a livello europeo, pari al 95,2%. Il dato riguarda medicinali e un preciso periodo di osservazione: non significa che il 95,2% delle malattie rare abbia una terapia, né che la stessa quota dei pazienti abbia ricevuto un trattamento. [1]

Tre problemi devono essere affrontati insieme. Il primo è scientifico: popolazioni limitate e patologie eterogenee rendono difficile produrre evidenze robuste. Il secondo è organizzativo: diagnosi, centri, laboratori, farmacie e servizi territoriali devono funzionare come un percorso. Il terzo è economico: costi, incertezza sugli esiti e distribuzione delle responsabilità finanziarie richiedono decisioni sostenibili e trasparenti.

La proposta centrale è un programma nazionale per l'accesso effettivo ai farmaci per le malattie rare, collocato nella governance esistente. Il programma dovrebbe essere coordinato dal Ministero della Salute, con indirizzo del Comitato nazionale per le malattie rare e responsabilità operative di AIFA, Regioni, centri e aziende sanitarie secondo le rispettive competenze. Non occorre attribuire al Comitato poteri di negoziazione del prezzo o di prescrizione che non gli appartengono.

Il programma dovrebbe partire da un numero circoscritto di percorsi prioritari e da una misurazione condivisa dei tempi. La selezione dovrebbe considerare rischio di danno irreversibile, disponibilità di trattamenti con beneficio dimostrato, complessità del percorso e vulnerabilità delle famiglie. La rapidità deve essere accompagnata da appropriatezza, sicurezza e capacità di rivalutare le decisioni.

Questo documento propone un'agenda operativa e ne esplicita i limiti. Non assegna giudizi complessivi alle singole Regioni senza dati comparabili; non presenta le aziende come sostituti del SSN; non considera il finanziamento di un progetto di ricerca equivalente a un risultato clinico.

Le decisioni proposte

La prima decisione è introdurre una rendicontazione pubblica dell'attuazione delle politiche per le malattie rare. Per ciascuna misura dovrebbero essere visibili il responsabile, il provvedimento necessario, le risorse, la scadenza e il risultato osservabile. Un calendario di riunioni, una norma approvata e una terapia somministrata sono eventi diversi e vanno registrati separatamente.

La seconda decisione è definire uno standard nazionale del percorso di accesso. Lo standard dovrebbe comprendere invio al centro, diagnostica necessaria, valutazione di eleggibilità, approvvigionamento, prima erogazione e follow-up. Le Regioni manterrebbero l'organizzazione dei servizi, ma utilizzerebbero definizioni comuni dei passaggi e dei dati. I percorsi urgenti dovrebbero avere priorità clinicamente motivata e un meccanismo di escalation quando un ritardo rischia di produrre un danno irreversibile.

La terza decisione è finanziare la capacità dei servizi insieme al farmaco. Per una terapia genica, per esempio, non basta un capitolo di spesa per l'acquisto: servono valutazione multidisciplinare, disponibilità del centro, gestione dei rischi e sorveglianza. Per una terapia cronica servono rinnovi, distribuzione prevedibile e assistenza vicina al domicilio quando appropriata. Questi costi devono comparire nelle valutazioni di impatto sul bilancio.

La quarta decisione è costruire un sistema di dati proporzionato alla rarità. Registri e flussi amministrativi dovrebbero consentire di stimare quanti pazienti eleggibili restano in attesa, perché attendono e quali esiti ottengono. La raccolta deve essere limitata a informazioni utili, con basi giuridiche, responsabilità e controlli definiti. La disponibilità di dati non autorizza automaticamente ogni loro riuso.

La quinta decisione è rendere esplicito il rapporto tra accesso e incertezza. Quando il beneficio è sufficientemente documentato e l'urgenza elevata, occorre ridurre le attese evitabili. Quando le prove sono fragili, l'accesso deve essere accompagnato da condizioni, ricerca e rivalutazione. Quando un beneficio non viene confermato, la comunicazione e la transizione assistenziale devono essere organizzate con la stessa cura dedicata all'introduzione del farmaco.

L'avvio proposto è di dodici mesi, con una prima fase di novanta giorni per definire dati, responsabilità e percorsi pilota. Le scadenze e gli indicatori contenuti nelle sezioni finali sono proposte del white paper, non obblighi già vigenti o risultati già ottenuti. L'adozione richiederebbe atti delle amministrazioni competenti e, dove necessario, coperture finanziarie e adeguamenti normativi.

01 Ambito e metodo

Il white paper considera l'accesso ai medicinali per le malattie rare in Italia lungo l'intero percorso del paziente. Comprende farmaci con designazione orfana, terapie utilizzate in patologie rare senza tale designazione e strumenti di accesso anticipato o fuori indicazione nelle condizioni previste dall'ordinamento. Il tema dei tumori rari è richiamato quando pertinente, senza sovrapporlo automaticamente alle malattie rare non oncologiche.

La ricerca è documentale e orientata alle decisioni pubbliche. Le fonti principali sono atti normativi, documenti di AIFA, EMA, Ministero della Salute, ISS e Conferenza Stato-Regioni; si aggiungono rapporti della federazione dei pazienti e uno studio originale sui tempi regionali. Le notizie e i comunicati sono utilizzati entro il loro perimetro: un annuncio testimonia una decisione comunicata, mentre un atto e i dati di erogazione documentano livelli successivi.

Le evidenze sono classificate in quattro categorie. Il fatto verificato è sostenuto da una fonte identificabile. L'interpretazione spiega il significato possibile del fatto e non pretende di dimostrare un rapporto causale. La proposta indica una scelta da discutere e adottare. Il punto non accertato segnala una lacuna informativa, senza trasformarla in un giudizio di inerzia o di mancata attuazione.

La data di chiusura documentale è il 7 ottobre 2026. Il periodo dei dati viene indicato separatamente: una pubblicazione del 2026 può contenere valori del 2024 o del 2025. Per i medicinali, l'autorizzazione europea è distinta dalla rimborsabilità italiana, che può essere limitata a specifiche età, forme cliniche e condizioni. Il riferimento operativo resta il provvedimento vigente e, quando previsto, la scheda di eleggibilità aggiornata.

I casi aziendali sono selezionati per mostrare problemi differenti, non per costruire una graduatoria commerciale. Non viene effettuato un confronto indiretto di efficacia tra patologie o prodotti diversi. Non sono stati raccolti dati individuali né condotte interviste, verifiche presso tutti i centri o un censimento aggiornato dei tempi nelle ventuno Regioni e Province autonome.

L'analisi non è una revisione sistematica della letteratura clinica. Le raccomandazioni organizzative sono motivate dai meccanismi descritti, ma richiedono sperimentazione e valutazione. Il documento non fornisce indicazioni terapeutiche individuali e non sostituisce la decisione clinica o regolatoria.

02 Rarità e bisogno terapeutico

La rarità non identifica un'unica categoria clinica. Una patologia può manifestarsi alla nascita, in età adulta o dopo un lungo periodo di sintomi non specifici. Può avere un'origine genetica, richiedere competenze di più specialità o determinare disabilità e bisogni assistenziali persistenti. La programmazione deve quindi evitare un modello costruito esclusivamente sul bambino o esclusivamente sul farmaco.

Nel quadro europeo la designazione orfana richiede condizioni specifiche, tra cui gravità della malattia e rarità, oppure insufficiente ritorno economico atteso; rilevano inoltre l'assenza di metodi soddisfacenti o un beneficio significativo rispetto a quelli esistenti. La soglia di riferimento per la prevalenza è non superiore a cinque persone ogni diecimila. La designazione favorisce lo sviluppo, ma non dimostra di per sé efficacia, sicurezza o diritto al rimborso. [3]

Occorre distinguere almeno tre bisogni. Esiste il bisogno di una terapia causale quando manca un trattamento in grado di modificare la malattia. Esiste il bisogno di accesso quando un trattamento

appropriato è disponibile ma il percorso non consente di raggiungerlo in tempo. Esiste il bisogno assistenziale quando la persona necessita comunque di riabilitazione, supporto nutrizionale, gestione dei sintomi, assistenza psicologica o servizi sociali.

Confondere questi piani porta a proposte incomplete. Ridurre una procedura amministrativa non risolve l'assenza di una terapia efficace. Finanziare ricerca non risolve nell'immediato una carenza di capacità del centro. Introdurre un nuovo medicinale non elimina automaticamente disabilità, bisogni familiari o necessità di monitoraggio. Ogni intervento deve dichiarare quale bisogno affronta e con quale orizzonte temporale.

La nozione di beneficio merita la stessa precisione. Una cura definitiva, un miglioramento funzionale, un rallentamento della progressione e un sollievo sintomatico non sono equivalenti. Possono avere tutti valore, ma richiedono indicatori differenti. La comunicazione pubblica dovrebbe utilizzare risultati specifici e comprensibili, evitando di descrivere ogni innovazione come una guarigione.

La proposta è organizzare la programmazione per gruppi di percorsi con problemi simili: condizioni con finestra terapeutica stretta, patologie che richiedono diagnostica molecolare, terapie croniche complesse e forme prive di trattamento specifico. Questa classificazione operativa non sostituisce le classificazioni cliniche; serve a rendere riconoscibili le responsabilità e a scegliere interventi adeguati.

03 La fotografia italiana

La lettura del sistema italiano deve affiancare disponibilità terapeutica, organizzazione della rete e condizioni di vita dei pazienti. Il comunicato di presentazione di MonitoRare 2026 riporta 275 centri di riferimento e oltre 361 PDTA regionali, con tutte le Regioni e Province autonome che hanno recepito il Piano nazionale 2023–2026. Lo stesso quadro segnala mobilità sanitaria e difficoltà di attuazione. La presenza di una rete costituisce una risorsa; il numero di strutture non misura da solo capacità, tempi e qualità. [1]

Il riepilogo MonitoRare riporta oltre 520.000 persone viventi inserite nei registri regionali al 31 dicembre 2024, a fronte di una stima epidemiologica complessiva di 2,1–3,5 milioni. La mobilità interregionale stimata sui registri è del 18%, e del 24% nei minori. Sono popolazioni e misure differenti, non valori da sottrarre per calcolare automaticamente quanti pazienti siano privi di assistenza. [22]

Per la sorveglianza, il Registro nazionale malattie rare dell'ISS è uno strumento istituzionale di riferimento. Il settimo rapporto riguarda il biennio 2022–2023 ed è stato pubblicato nel gennaio 2026. I registri amministrativi e di patologia hanno perimetri diversi: persone registrate, titolari di esenzione e stime epidemiologiche non possono essere utilizzati come sinonimi. [2]

Queste differenze incidono sul denominatore dell'accesso. Se si considera soltanto chi ha una diagnosi e compare in un registro, chi è ancora senza diagnosi può restare fuori dalla misurazione. Se si conta una prima dispensazione regionale, non si conosce necessariamente il numero di pazienti trattati. Se si osserva la presenza di un PDTA, non si sa automaticamente se il percorso abbia personale, appuntamenti e finanziamenti sufficienti.

Una fotografia utile dovrebbe quindi integrare tre livelli. Il livello di popolazione descrive persone e bisogni. Il livello dei servizi descrive la capacità operativa. Il livello della terapia descrive eleggibilità, trattamento e risultati. Il collegamento deve preservare la qualità dei dati, evitare duplicazioni e consentire analisi per età e territorio.

Il documento non formula una graduatoria regionale aggiornata al 2026. Mancano, nelle fonti utilizzate, serie omogenee per tutti i passaggi del percorso e per tutte le Regioni. È invece possibile riconoscere una priorità:

passare da un inventario delle risorse a una verifica di funzionamento. Un centro dovrebbe essere descritto attraverso competenze, percorsi coperti, tempi e modalità di contatto; un PDTA attraverso attuazione, popolazione raggiunta ed esiti.

Il risultato atteso della proposta non è produrre una nuova fotografia una tantum. È costruire una base informativa che possa essere aggiornata e che permetta ai decisori di distinguere carenze strutturali, ritardi episodici e difficoltà dipendenti dalla complessità clinica.

04 Il percorso dall'innovazione al paziente

L'accesso ordinario a un medicinale comporta passaggi distinti. La valutazione scientifica europea e la decisione di autorizzazione definiscono il rapporto beneficio–rischio e l'indicazione. In Italia la valutazione e la negoziazione di prezzo e rimborso sono di competenza AIFA. L'organizzazione regionale e aziendale deve poi tradurre la decisione in prescrizione, disponibilità e somministrazione. La diagnosi e l'eleggibilità clinica attraversano più punti del percorso e non iniziano necessariamente dopo l'autorizzazione.

Questa sequenza non va rappresentata come un semplice cronometro unico. Tra autorizzazione europea e presentazione del dossier italiano possono trascorrere tempi attribuibili alla strategia del titolare o alla preparazione documentale. Nel procedimento nazionale possono esistere richieste di integrazione e fasi negoziali. Dopo la decisione possono essere necessari centri autorizzati, formazione, capacità tecnica e approvvigionamento. Separare le fasi consente di intervenire sul problema corretto.

La diagnosi deve essere abbastanza precisa da orientare la scelta terapeutica. Nei trattamenti rivolti a specifiche varianti genetiche, una diagnosi generica della patologia può non essere sufficiente. Devono essere chiari il laboratorio competente, il significato del risultato, l'eventuale necessità di conferma e il servizio che comunica l'esito alla famiglia.

La prescrizione richiede che il paziente soddisfi le condizioni previste. Non ogni persona con la stessa malattia ha necessariamente la stessa indicazione o lo stesso profilo di rischio. Il controllo dell'appropriatezza tutela il paziente e le risorse pubbliche; diventa un ostacolo evitabile quando gli stessi dati vengono richiesti ripetutamente senza una ragione clinica o normativa.

La prima erogazione apre una nuova fase. Vanno assicurati controlli, gestione degli eventi avversi, rinnovi, eventuali sospensioni motivate e passaggi tra servizi. Una misurazione che si arresta alla prima dose può ignorare la difficoltà più importante per una terapia cronica: continuare a riceverla.

La proposta è utilizzare un fascicolo di percorso con eventi datati e responsabili identificati, senza trasformarlo in una cartella parallela. Il fascicolo dovrebbe permettere al centro di riconoscere quale passaggio è bloccato e al coordinamento regionale di risolvere le interruzioni. La preparazione dei servizi può iniziare prima del rimborso attraverso programmazione del fabbisogno, senza anticipare una decisione clinica o finanziaria ancora non adottata.

05 Diagnosi e screening

Il ritardo diagnostico è una barriera all'accesso anche quando il farmaco esiste. La persona può attraversare più specialità, ricevere spiegazioni parziali e ripetere esami senza che qualcuno ricomponga il quadro. Per le condizioni con danno irreversibile progressivo, il tempo della diagnosi può incidere sul beneficio potenzialmente ottenibile. L'urgenza deve essere determinata per patologia e situazione clinica, non dedotta dalla sola etichetta di malattia rara.

Al 7 ottobre 2026 il quadro degli screening è in transizione. Il Portale istituzionale delle malattie rare documenta l'aggiornamento dei LEA pubblicato a fine settembre, con inserimento dello screening per la SMA e ampliamento ad altre patologie. La fonte precisa l'entrata in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. Il provvedimento adottato non deve quindi essere presentato, alla data di questo documento, come copertura operativa già verificata in ogni territorio. [8]

L'attuazione dello screening richiede l'intera filiera: prelievo, trasporto, analisi, richiamo, conferma, consulenza e presa in carico. L'aggiunta di una patologia al pannello perde efficacia organizzativa se il laboratorio identifica il sospetto ma il servizio non riesce a contattare la famiglia o a confermare rapidamente il risultato. Occorre inoltre distinguere un test positivo da una diagnosi definitiva.

La proposta è un cruscotto dei percorsi di screening, con indicatori sul tempo tra nascita e campionamento, ricezione del campione, risultato, comunicazione, conferma e valutazione specialistica. I target devono essere definiti dalle competenze cliniche e di laboratorio, evitando un unico tempo standard per tutte le condizioni. I casi critici devono avere un contatto clinico disponibile e un percorso di escalation.

Per le diagnosi non neonatali, il modello dovrebbe comprendere criteri di sospetto per medici e pediatri, accesso alla consulenza specialistica e rivalutazione dei casi irrisolti. La formazione dovrebbe essere basata su situazioni ricorrenti e su modalità di invio, non sulla memorizzazione di migliaia di patologie.

La valutazione economica deve includere conferme diagnostiche e conseguenze dei risultati incerti. Ampliare i test senza finanziare interpretazione, counselling e capacità dei centri rischia di trasferire il problema a valle. Un programma ben organizzato dovrebbe misurare quanti risultati producono una decisione utile e quanti lasciano la famiglia in una nuova fase di attesa.

06 Genomica e pazienti senza diagnosi

La diagnostica genomica può orientare l'accesso ai farmaci, ma il valore del test dipende dalla domanda clinica, dalla qualità tecnica e dall'interpretazione. Una variante identificata non è automaticamente una causa di malattia e non implica necessariamente una terapia disponibile. La programmazione deve prevedere anche il risultato negativo, la variante di significato incerto e l'eventualità di una rianalisi.

La risposta parlamentare del 25 marzo 2026 descriveva ancora in istruttoria il decreto di riparto del Fondo per i test NGS per le malattie rare e indicava interlocuzioni con Regioni e SIGU. Questo è uno stato documentato a marzo. La ricerca svolta per il white paper non consente di attestare in modo conclusivo l'intero stato successivo del riparto e della concreta erogazione nazionale al 7 ottobre. [7]

La priorità operativa è individuare un percorso e non soltanto un finanziamento. Il percorso dovrebbe stabilire chi richiede il test, quali quesiti giustificano l'accesso, dove viene eseguito, quali tempi sono attesi e chi restituisce il risultato. Per casi complessi, la valutazione collegiale tra clinici, genetisti e laboratorio

dovrebbe rendere esplicita la relazione tra fenotipo e dato molecolare.

Per i pazienti senza diagnosi, si propone un coordinamento che assicuri la continuità tra una valutazione e la successiva. Un esito negativo dovrebbe produrre un piano: ulteriori indagini quando indicate, rianalisi in condizioni definite, assistenza dei sintomi e possibilità di consulto nella rete. L'assenza di un'etichetta diagnostica non dovrebbe interrompere i servizi clinicamente necessari.

La qualità richiede un sistema di tracciabilità della rianalisi: data, nuove conoscenze disponibili, esito e conseguenze sul percorso. Non è utile ripetere indiscriminatamente lo stesso esame; può invece essere utile rivalutare informazioni già raccolte quando la conoscenza cambia. La modalità va definita in base alle risorse e alle indicazioni appropriate.

La proposta di finanziamento distingue prestazione, interpretazione e coordinamento. Una tariffa che remunera soltanto la produzione del dato può lasciare scoperta la parte che determina la decisione clinica. Gli indicatori suggeriti sono tempo al referto, quota di risultati restituiti con consulenza, quota di diagnosi utilizzabili e tempo dal risultato alla valutazione terapeutica. Non viene fissata una percentuale universale di successo diagnostico, perché varia con popolazione e selezione dei casi.

07 Valutazione AIFA e tempi di accesso

La negoziazione nazionale è uno dei passaggi più visibili, ma non esaurisce l'accesso. La valutazione deve considerare beneficio clinico, comparatori, qualità delle prove e condizioni economiche. Per i farmaci destinati a piccole popolazioni, l'incertezza sui risultati a lungo termine può rendere più complessa la decisione, senza giustificare attese prive di una motivazione identificabile.

Il comunicato AIFA sul rapporto 2024–2026 indica circa quattro mesi come tempo medio di valutazione dei dossier gestiti da aprile 2024 a dicembre 2025, con circa due mesi per i generici e sette per le altre tipologie negoziali. La media generale non è una misura specifica dei farmaci orfani, né rappresenta il tempo dall'autorizzazione europea alla cura del paziente. [15]

Uno studio originale sui dati 2016–2021 ha esaminato l'intervallo dalla trasmissione in Gazzetta della determina alla prima movimentazione regionale dei farmaci orfani, riportando una mediana nazionale di 113 giorni. È una misura storica di un evento distributivo, non una stima aggiornata al 2026 dell'attesa individuale. Non va sommata alla media AIFA recente per costruire un tempo totale, perché periodi, popolazioni ed eventi sono diversi. [16]

La proposta è pubblicare tempi distinti per categoria e fase. Per i dossier devono essere definiti avvio, richieste di integrazione, tempi sospesi, conclusione scientifica ed economica, decisione e pubblicazione. Per il territorio devono essere definiti operatività del centro, disponibilità del prodotto e trattamento del paziente. I procedimenti ancora aperti devono comparire, altrimenti un'analisi limitata ai soli casi conclusi può descrivere in modo incompleto la situazione.

L'obiettivo non è comprimere ogni valutazione allo stesso numero di giorni. È riconoscere ciò che richiede un'analisi rigorosa e ciò che può essere organizzato in parallelo. La previsione del fabbisogno, l'identificazione preliminare delle competenze e la preparazione dei sistemi possono ridurre tempi a valle senza condizionare l'esito della negoziazione.

Il monitoraggio dovrebbe distinguere responsabilità pubbliche e attività del titolare. Un dossier incompleto, una negoziazione complessa e una difficoltà di approvvigionamento sono problemi diversi. Rendere visibili le cause dell'attesa consente un confronto più utile tra istituzioni, imprese e pazienti e riduce il rischio di

attribuzioni generiche.

08 Regioni e capacità dei centri

Il territorio è il punto in cui una decisione nazionale diventa un servizio. La Regione organizza la rete e le aziende sanitarie rendono disponibili professionisti, farmacie, laboratori e appuntamenti. La qualità del centro dipende dalla competenza, ma anche dalla capacità di assorbire il fabbisogno e di mantenere il collegamento con il luogo di vita del paziente.

L'articolo 5 della legge 175/2021 prevede canali di erogazione per i farmaci di fascia A o H prescritti per le malattie rare e stabilisce la disponibilità anche nelle more degli aggiornamenti dei prontuari regionali o locali. La disciplina contempla inoltre il caso della diagnosi effettuata in una Regione diversa da quella di residenza. Le condizioni cliniche e prescrittive del medicinale restano rilevanti. [4]

La proposta è un protocollo regionale di attivazione che traduca la determina nazionale in compiti nominativi. Devono essere identificati centro prescrittore, farmacia, gestione degli ordini, copertura economica, referente per i pazienti fuori Regione e disponibilità del follow-up. Per una nuova indicazione, il protocollo dovrebbe aggiornare il percorso esistente quando possibile, evitando di ricominciare ogni volta l'intera costruzione organizzativa.

La concentrazione della competenza può essere appropriata, soprattutto per procedure ad alto rischio o tecnicamente complesse. L'equità non richiede necessariamente che ogni terapia sia somministrata in ogni provincia. Richiede che la distanza non renda il percorso impraticabile e che le attività trasferibili al territorio vengano effettivamente trasferite con responsabilità e sicurezza.

Un modello di centro esperto collegato a servizi territoriali dovrebbe definire quali controlli devono restare centralizzati, quali possono essere svolti vicino al domicilio e come vengono condivisi i risultati. La decisione va presa per terapia e profilo clinico. La telemedicina può sostenere alcuni contatti, ma non sostituisce automaticamente esami, infusioni o valutazioni fisiche necessarie.

Gli indicatori proposti sono tempo alla prima visita, tempo all'inizio del trattamento dopo la decisione clinica, disponibilità di personale dedicato e quota di attività di controllo svolte nel territorio quando appropriate. La capacità non va misurata solo con il volume: per patologie ultrarare possono contare anche competenze, rete di consulenza e continuità. La rendicontazione dovrebbe esplicitare dove un centro ha limiti e quale soluzione è disponibile per il paziente.

09 Accesso anticipato e fuori indicazione

L'Italia dispone di strumenti differenti per consentire, in condizioni determinate, l'accesso prima del percorso ordinario o fuori dall'indicazione autorizzata. La legge 648/1996 e il Fondo nazionale AIFA prevedono forme di rimborso pubblico con presupposti e procedure specifici. L'uso compassionevole richiede disponibilità alla fornitura gratuita da parte dell'azienda e parere favorevole del comitato etico competente. Non sono percorsi intercambiabili. [17,18]

La presenza dello strumento non implica che ogni richiesta sia accolta. Devono essere valutati evidenze, necessità clinica, alternative e requisiti applicabili. La responsabilità del clinico, il consenso informato e la sorveglianza restano centrali. L'urgenza non elimina il bisogno di una decisione motivata; impone che la

procedura sia organizzata in modo da non introdurre tempi evitabili.

La criticità operativa possibile è la frammentazione delle richieste. Un centro esperto può avere capacità di gestire documenti, interlocuzioni e follow-up che una struttura meno attrezzata non possiede. Per il paziente, questa differenza può tradursi in maggiore dipendenza dalla capacità di orientarsi nel sistema. Il white paper propone un supporto tecnico regionale per i centri, senza sostituire la valutazione nazionale o il giudizio clinico.

Il supporto dovrebbe aiutare a individuare il canale appropriato, verificare la completezza dei documenti e mantenere una traccia dell'esito. Sarebbe utile un elenco pubblico dei programmi attivi con criteri, contatti, eventuali limiti di fornitura e aggiornamenti, evitando di pubblicare informazioni che possano identificare singoli pazienti.

La fase più delicata è il passaggio al rimborso ordinario o la chiusura del programma. Occorre sapere chi assicura la fornitura durante la transizione, quali controlli continuano e come vengono comunicati cambiamenti di eleggibilità. L'accesso precoce non dovrebbe generare una presa in carico senza un piano per la fase successiva.

Una riforma organica può essere discussa, ma dovrebbe partire da una valutazione dei percorsi esistenti: richieste, esiti, tempi, popolazioni raggiunte e sostenibilità. Un nuovo canale non è utile se replica gli stessi problemi amministrativi. La raccomandazione immediata è migliorare trasparenza, assistenza ai centri e continuità, mantenendo le garanzie scientifiche e regolatorie.

10 Casi aziendali e criteri di lettura

I casi scelti mostrano quattro situazioni: una terapia consolidata con ampliamento dell'eleggibilità, una terapia genica con forte dipendenza dalla tempestività e dall'organizzazione, una terapia per una condizione ultrarara e un medicinale il cui beneficio non è stato confermato secondo le richieste regolatorie. La selezione non rappresenta tutte le aziende o tutte le tecnologie e non indica preferenze di acquisto.

Le aziende citate sono Vertex per Kaftrio, Novartis per Zolgensma, Alexion per Strensiq e PTC Therapeutics per Translarna. Il risultato di uno sviluppo terapeutico nasce anche dalla ricerca accademica, dai centri, dai pazienti e dal lavoro delle autorità. Attribuire un risultato clinico al programma del prodotto non implica attribuire all'impresa l'intero cambiamento dell'assistenza.

Ogni caso viene letto su tre piani. Il primo è l'evidenza: popolazione studiata, risultato e disegno dello studio. Il secondo è il quadro regolatorio: indicazione e decisione europea. Il terzo è l'accesso italiano: provvedimento di rimborsabilità e requisiti organizzativi. Quando mancano dati pubblici sul numero di persone trattate o sui tempi individuali, il documento lo esplicita.

L'entità dell'effetto clinico non deve essere confrontata tra prodotti con esiti diversi. Un incremento di funzione respiratoria, la sopravvivenza senza ventilazione e un miglioramento radiografico rispondono a domande differenti. La qualità delle prove va giudicata dentro la patologia, considerando gravità, storia naturale, alternative e durata dell'osservazione.

La stessa cautela vale per l'accesso. La prima autorizzazione europea, la prima rimborsabilità nazionale e una successiva estensione possono riferirsi a popolazioni differenti. Un intervallo di molti anni tra due date non è automaticamente un ritardo negoziale relativo alla stessa indicazione. Per una valutazione corretta occorrono il dossier, il periodo pertinente e gli strumenti di accesso eventualmente disponibili.

Le lezioni organizzative dei casi sono proposte di questo white paper. Non vengono presentate come condizioni già applicate a tutti i prodotti citati. L'intento è rendere concreto il confronto: per quali pazienti il trattamento può avere valore, quali passaggi possono ostacolare l'accesso e quali informazioni servono per valutare il risultato senza affidarsi a dichiarazioni promozionali.

11 Vertex e la fibrosi cistica

Kaftrio associa elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor e viene utilizzato insieme a ivacaftor. Nel primo studio principale descritto da EMA, su 403 pazienti con una mutazione F508del e una mutazione a funzione minima, a ventiquattro settimane il ppFEV1 aumentava in media di 13,9 punti percentuali nel gruppo trattato, contro una riduzione di 0,4 nel gruppo placebo. La differenza tra i cambiamenti è di 14,3 punti percentuali; non va descritta come un aumento del 14,3% per ogni paziente. [10]

Il risultato illustra il valore di una terapia che interviene sul difetto funzionale. Non dimostra una guarigione universale e non va trasferito automaticamente a tutte le età o varianti. Le prove per popolazioni diverse vanno considerate separatamente, insieme alla sicurezza e alla necessità di controlli.

Per l'Italia, la determina AIFA PRES/168/2026 rimborsa le nuove indicazioni per pazienti con almeno una mutazione non di classe I del gene CFTR: compresse da sei anni e granulato da due a meno di sei anni. La prescrizione è limitata ai centri di cura della fibrosi cistica. Il provvedimento dispone anche la chiusura dei precedenti registri per le indicazioni indicate; la comunicazione AIFA ne colloca l'effetto al 19 febbraio 2026. La chiusura del monitoraggio non equivale alla cessazione del rimborso. [11,12]

La lezione operativa riguarda la gestione dell'ampliamento. Il centro deve identificare i pazienti potenzialmente eleggibili, aggiornare l'informazione, valutare i risultati genetici e organizzare i controlli. La disponibilità normativa non informa da sola su quante persone siano state rivalutate dopo l'estensione.

Si propone un indicatore di percorso: quota di pazienti già seguiti dal centro che ricevono una verifica documentata dell'eleggibilità dopo un cambiamento di indicazione. Il denominatore deve essere definito e la mancata prescrizione deve distinguere non eleggibilità, controindicazione, scelta informata e attesa organizzativa. In questo modo il sistema può riconoscere un problema senza confondere ogni mancato trattamento con un accesso negato.

Le fonti consultate non permettono di quantificare in modo completo, al 7 ottobre 2026, il numero di pazienti italiani trattati nelle nuove indicazioni o l'attesa nei singoli centri. Il caso documenta quindi un risultato clinico e una decisione nazionale, non un esito operativo uniforme già dimostrato.

12 Novartis e la terapia genica nella SMA

Zolgensma contiene onasemnogene abeparvovec e rappresenta un esempio di terapia genica per la SMA. Nello studio descritto da EMA, venti dei ventidue bambini erano vivi senza necessità di ventilazione permanente a quattordici mesi di età; quattordici erano in grado di stare seduti senza sostegno per almeno trenta secondi a diciotto mesi. Sono risultati di una piccola coorte e non di un confronto randomizzato con tutte le alternative disponibili. [13]

La lettura deve considerare la popolazione dello studio e la storia naturale utilizzata come riferimento. La dimensione del campione e l'osservazione limitata non autorizzano previsioni individuali o affermazioni di

durata illimitata del beneficio. La terapia richiede selezione, competenza e gestione della sicurezza secondo le informazioni aggiornate del medicinale.

La comunicazione AIFA del marzo 2024 documenta rimborsabilità per la SMA 5q in pazienti con peso fino a 13,5 chilogrammi, con diagnosi clinica di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi oppure mutazione biallelica SMN1 e fino a tre copie SMN2. Sono previsti criteri di eleggibilità e prescrizione tramite registro e centri autorizzati. Il perimetro italiano non deve essere dedotto dalla sola descrizione generale dell'indicazione europea. [14]

La lezione di politica sanitaria è che l'accesso a una terapia complessa dipende dalla preparazione del percorso. Screening, conferma diagnostica, invio al centro e valutazione devono essere coordinati. Per le condizioni con una finestra di intervento clinicamente rilevante, il servizio deve sapere in anticipo quale centro contattare e come affrontare un impedimento logistico.

Si propone un percorso prioritario per i nuovi sospetti diagnostici, con tempi clinicamente definiti e responsabilità del trasferimento. Il programma dovrebbe misurare l'intervallo dalla conferma alla decisione, distinguendolo dall'intervallo dalla decisione alla somministrazione. Devono essere registrati anche i pazienti non trattati e le motivazioni, per evitare una fotografia limitata ai soli successi organizzativi.

Il costo del percorso comprende valutazione, assistenza e follow-up, oltre al prodotto. Eventuali accordi economici legati ai risultati devono avere criteri verificabili, senza imporre ai centri una raccolta sproporzionata. Le fonti citate non costituiscono un censimento aggiornato dei pazienti italiani trattati o una comparazione tra le diverse terapie della SMA.

13 Alexion e l'ipofosfatasia

Strensiq contiene asfotase alfa ed è una terapia enzimatica sostitutiva per l'ipofosfatasia. La documentazione EMA descrive uno studio principale su tredici bambini tra sei e dodici anni, con valutazione del miglioramento radiografico di polsi e ginocchia. Le prove considerate dall'autorità comprendono miglioramenti della struttura scheletrica e altri elementi di beneficio, con i limiti propri di piccoli studi in una patologia rara. [19]

Il risultato deve essere interpretato nella popolazione pertinente. Un miglioramento radiografico non riassume automaticamente dolore, autonomia, funzione respiratoria o qualità della vita. Gli esiti possono essere collegati, ma non sono intercambiabili. La definizione del valore terapeutico richiede un insieme di misure clinicamente appropriate e una lettura della gravità iniziale.

La comunicazione AIFA del 28 gennaio 2025 indica rimborsabilità per l'ipofosfatasia a esordio pediatrico entro sei mesi e per i pazienti con esordio pediatrico più tardivo affetti da forma severa, secondo criteri di eleggibilità e appropriatezza previsti nelle schede. Il caso mostra come esordio, severità e indicazione rimborsata debbano essere letti insieme. [20]

La lezione organizzativa riguarda il paziente ultrarraro. Il numero limitato di casi può rendere difficile sviluppare esperienza in molti territori. Un sistema equo deve rendere possibile il consulto esperto e sostenere la continuità del percorso, senza richiedere alle famiglie di costruire autonomamente una rete di contatti.

Si propone una valutazione multidisciplinare documentata per i casi complessi e un piano condiviso tra centro, farmacia e servizi locali. Il piano dovrebbe chiarire modalità di somministrazione, formazione del paziente o del caregiver quando pertinente, controlli e gestione degli eventi che richiedono rivalutazione. Il

modello deve essere adattato alle condizioni cliniche, evitando una delega indiscriminata al domicilio.

Per misurare il risultato del percorso si suggeriscono continuità della fornitura, disponibilità dei controlli e tempi del consulto esperto. Gli esiti clinici dovrebbero essere definiti dal gruppo competente per la patologia e non ricavati da un modello economico generico.

Le date di autorizzazione europea e della comunicazione italiana qui citata non sono utilizzate per calcolare un ritardo totale: possono riferirsi a fasi e condizioni diverse e non descrivono tutti i possibili accessi precedenti. Non è disponibile, nelle fonti esaminate, una misura completa dell'accesso effettivo italiano al 7 ottobre 2026.

14 PTC Therapeutics e il caso Translarna

Il caso Translarna, contenente ataluren, mostra perché un white paper sull'accesso deve includere anche i limiti dell'innovazione. EMA documenta che il 28 marzo 2025 la Commissione europea ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione condizionata. La valutazione regolatoria ha ritenuto che l'efficacia non fosse stata confermata adeguatamente. La gravità della malattia e il bisogno di trattamento non sostituiscono la dimostrazione richiesta del beneficio. [21]

La conclusione non è che l'accesso anticipato sia sbagliato. È che l'accesso in condizioni di incertezza richiede un patto verificabile: quali prove devono essere prodotte, entro quando, con quali esiti e con quali conseguenze se il risultato non conferma le aspettative. L'incertezza deve essere comunicata fin dall'inizio, in modo comprensibile per pazienti e professionisti.

La criticità più delicata nasce quando un medicinale già utilizzato cambia stato regolatorio. Il paziente può interpretare il cambiamento come perdita di una possibilità, mentre il sistema deve tutelarlo attraverso una decisione scientifica e una presa in carico continua. La transizione non può essere lasciata alla sola comunicazione commerciale o a un avviso amministrativo.

Si propone che ogni percorso di accesso condizionato preveda una gestione della rivalutazione. Devono essere identificati il servizio che contatta il paziente, la modalità di revisione della terapia, l'assistenza di supporto e gli eventuali percorsi legalmente applicabili. Il documento non presume l'esistenza di un particolare canale di fornitura in Italia per questo prodotto al 7 ottobre 2026: le fonti utilizzate non lo accertano.

Il caso distingue quattro eventi spesso confusi: parere scientifico, decisione europea, applicazione nazionale e comportamento clinico. Un parere non deve essere presentato come decisione definitiva prima dell'atto competente; una decisione definitiva non deve essere ignorata perché il bisogno resta elevato.

Per il sistema pubblico, la lezione è valutare la qualità delle evidenze insieme all'urgenza e costruire piani di uscita o di transizione. Per le imprese, è la responsabilità di produrre prove adeguate e comunicare gli aggiornamenti. Per le associazioni, è la possibilità di contribuire a un'informazione comprensibile. La protezione del paziente comprende sia l'accesso a trattamenti utili sia la gestione rigorosa di quelli il cui beneficio non risulta confermato.

15 Sostenibilità e valore delle cure

Il prezzo del farmaco è una componente della sostenibilità, ma non coincide con il costo complessivo del percorso. Il documento di sintesi MonitoRare 2026 riporta per il 2024 una spesa per farmaci orfani di 2,363 miliardi di euro, pari all'8,3% della spesa farmaceutica nel perimetro del rapporto. La categoria dei farmaci orfani non esaurisce ogni costo delle malattie rare e non può essere utilizzata come conto economico complessivo di queste patologie. [22]

Per decidere occorre separare almeno quattro dimensioni: beneficio atteso, incertezza, impatto sul bilancio e capacità del servizio. Un medicinale può avere un beneficio rilevante ma un impegno finanziario concentrato; oppure un costo unitario inferiore ma una popolazione più ampia o una durata maggiore. Le decisioni devono rendere visibili queste differenze.

La proposta è affiancare alla negoziazione una valutazione dell'intero percorso. Vanno considerati diagnostica, somministrazione, monitoraggio, possibili ricoveri e conseguenze organizzative. Eventuali costi evitati devono essere documentati e non semplicemente presunti. Il beneficio per famiglia e caregiver deve essere descritto, distinguendo effetti osservati da stime modellistiche.

Il prezzo pubblicato non è necessariamente la spesa netta sostenuta dal SSN. Sconti, accordi e meccanismi di rimborso possono modificare l'esborso; alcune condizioni non sono pubbliche. Il white paper non ricostruisce prezzi netti non disponibili e non propone confronti aziendali basati su listini come se fossero costi effettivi.

Gli accordi legati agli esiti sono una possibilità, non una soluzione universale. Sono utili se l'esito è misurabile, il follow-up praticabile e l'onere amministrativo proporzionato. Se i dati richiesti non vengono raccolti o non sono verificabili, l'accordo può creare lavoro senza ridurre l'incertezza. Vanno definiti responsabilità, gestione delle perdite al follow-up e conseguenze economiche.

La programmazione pluriennale è particolarmente importante quando l'investimento iniziale è concentrato e i benefici si distribuiscono nel tempo. Qualsiasi meccanismo di pagamento dilazionato deve rispettare le regole contabili e contrattuali e non essere presentato come una copertura già esistente. L'obiettivo proposto è rendere compatibili innovazione e continuità del servizio attraverso valutazioni esplicite, scenari prudenti e una verifica successiva dei risultati.

16 Ricerca e produzione delle evidenze

La ricerca nelle malattie rare deve affrontare problemi specifici: piccoli campioni, variabilità del decorso e difficoltà di selezionare esiti sensibili al cambiamento. Questo non autorizza a rinunciare al rigore. Richiede disegni adeguati, comparatori motivati e un piano di produzione delle prove che continui quando l'accesso iniziale lascia domande aperte.

AIFA ha approvato nel giugno 2026 la graduatoria del bando di ricerca indipendente sulle malattie rare, con diciannove progetti ammessi e un importo complessivo di 17.554.208 euro. È un risultato documentato di finanziamento dell'Agenzia. Non prova che gli studi siano tutti completati, che abbiano risultati positivi o che il beneficio sia già arrivato ai pazienti; non va attribuito automaticamente al Tavolo tecnico o al CoNaMR. [9]

La proposta è rendere tracciabile il ciclo del progetto: assegnazione, avvio, reclutamento, conclusione, pubblicazione e possibile conseguenza sulle cure. La rendicontazione dovrebbe includere gli esiti negativi e

le difficoltà, perché anche un risultato non favorevole può evitare investimenti o trattamenti inefficaci. Il finanziamento non dovrebbe essere valutato soltanto dal numero di pubblicazioni.

Per le imprese, il confronto anticipato con competenze cliniche, autorità e rappresentanti dei pazienti può migliorare la scelta degli esiti e la fattibilità. Il confronto non deve anticipare una promessa di rimborso. Dovrebbe chiarire quali domande cliniche contano, quali dati sono necessari e quali elementi di incertezza resteranno anche dopo lo studio.

I dati raccolti nella pratica clinica possono integrare le sperimentazioni, ma richiedono qualità, definizioni comuni e gestione dei fattori confondenti. Un miglioramento osservato dopo il trattamento non dimostra da solo che il farmaco ne sia la causa. La storia naturale e i controlli esterni possono essere utili quando appropriati, con attenzione alle differenze tra popolazioni e periodi.

Il riposizionamento di farmaci esistenti merita uno spazio dedicato, perché può affrontare bisogni con minore interesse commerciale. Anche in questo caso servono prove, un percorso regolatorio e sostenibilità della fornitura. La priorità proposta è selezionare quesiti clinici rilevanti per i pazienti e coordinare ricerca, accesso e disponibilità del prodotto, senza confondere una possibilità biologica con una terapia già efficace.

16A Coordinamento europeo e disponibilità delle forniture

La dimensione europea è rilevante per la produzione delle evidenze e per la sostenibilità dello sviluppo in popolazioni piccole. Il regolamento europeo HTA si applica dal gennaio 2025 e introduce valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche. L'estensione ai medicinali orfani è prevista dal gennaio 2028, mentre le terapie avanzate possono già rientrare nel perimetro iniziale. Il coordinamento clinico europeo non determina automaticamente prezzo e rimborso in Italia. [25,26]

La proposta per il sistema italiano è preparare il raccordo tra domande europee e valutazione nazionale. Nei programmi di sviluppo dovrebbero essere discussi per tempo comparatori, esiti e popolazioni; i servizi dovrebbero prepararsi alle terapie in arrivo attraverso una previsione del fabbisogno. Questa attività anticipatoria non costituisce una promessa di autorizzazione o finanziamento, ma riduce il rischio di dover organizzare l'intero percorso soltanto dopo la decisione.

La disponibilità del prodotto richiede una responsabilità distinta da quella clinica. Per le piccole popolazioni, un'interruzione produttiva, un vincolo di trasporto o una difficoltà di programmazione può avere conseguenze rilevanti. Il documento non attribuisce una carenza specifica alle aziende citate: propone un sistema di prevenzione e risposta che consideri le caratteristiche della terapia.

Per ogni percorso prioritario dovrebbe essere definito un piano di continuità della fornitura: previsione dei pazienti, tempi dell'ordine, gestione delle scorte quando appropriata e contatto per gli impedimenti. Per prodotti individualizzati o procedure complesse, la programmazione deve includere le fasi di produzione e trasporto pertinenti. Il piano non può essere copiato da quello di un medicinale ordinario.

Quando emerge un problema, il servizio dovrebbe registrare causa, durata e pazienti potenzialmente coinvolti, con protezione dei dati. Le eventuali alternative devono essere decise dal clinico e valutate secondo le regole applicabili; il problema logistico non autorizza una sostituzione terapeutica automatica. La famiglia dovrebbe ricevere informazioni comprensibili e un referente.

Il criterio di successo proposto è la capacità di anticipare e risolvere le interruzioni evitabili. La collaborazione tra impresa e SSN deve riguardare informazioni utili e affidabili, con responsabilità contrattuali e istituzionali definite. La disponibilità di un farmaco nel catalogo nazionale e la sua disponibilità per un appuntamento concreto sono due livelli che il monitoraggio deve collegare.

17 Ministero AIFA e organismi di coordinamento

Il riferimento a un tavolo sulle malattie rare può indicare organismi diversi. Il Ministero ha annunciato il Tavolo tecnico in tema di malattie rare il 21 giugno 2021. La legge 175/2021 ha poi previsto il Comitato nazionale per le malattie rare, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento; la risposta parlamentare del marzo 2026 ne conferma l'insediamento nel gennaio 2023. AIFA partecipa al sistema di coordinamento, mantenendo le proprie competenze sui medicinali. [5,6,7]

Il Piano nazionale malattie rare 2023–2026 e il documento di riordino della rete sono stati approvati con l'Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2023. L'atto richiama il parere del Comitato. Questo collegamento documentale consente di riconoscere un contributo del CoNaMR al percorso di approvazione, senza attribuirgli da solo ogni successiva attività regionale. [23]

Nel giugno 2026 il Ministero ha presentato la Carta di Roma al primo Summit nazionale sulle politiche per le malattie rare, collegata al lavoro di tavoli tematici. La pubblicazione di un documento di indirizzo è un prodotto del confronto; l'attuazione delle sue proposte richiede atti e risorse delle amministrazioni competenti. Le pagine ministeriali individuate hanno restituito limitazioni tecniche alla lettura integrale, perciò non si ricostruiscono qui verbali, composizione completa o contenuti dettagliati dei singoli tavoli non verificati. [24]

Il documento di sintesi MonitoRare segnala il rinnovo della composizione del Comitato nel gennaio 2026. È un aggiornamento riportato dalla fonte associativa; in questa ricerca non è stato acquisito il decreto completo di rinnovo. Non viene quindi utilizzato per attestare nominativi, durata del mandato o tutti gli obblighi di funzionamento. [22]

La valutazione deve distinguere attività collegiale e decisioni amministrative. Il Comitato non negozia i prezzi dei singoli farmaci; una graduatoria di ricerca AIFA non prova da sola un risultato del Tavolo; una delibera regionale richiede verifica della sua attuazione.

La raccomandazione è utilizzare la governance esistente per un registro pubblico delle decisioni. Per ogni indicazione formulata dagli organismi dovrebbe essere visibile il seguito: recepita, in istruttoria, non accolta con motivazione, oppure attuata e misurata. Questo renderebbe valutabile il contributo del coordinamento senza trasformarlo in un nuovo livello autorizzativo per il paziente.

18 Stato di attuazione e nota di trasparenza

La nota richiesta sul lavoro istituzionale deve evitare due errori: dare per attuata una misura annunciata e dichiarare inattività sulla base dell'assenza di documenti trovati. Le fonti consentono di attestare costituzione degli organismi, approvazione del Piano, finanziamenti e aggiornamento dei LEA. Non consentono una rendicontazione completa di ogni proposta, verbale e risultato del Tavolo e del Comitato fino al 7 ottobre 2026.

Per il Fondo di solidarietà, il credito d'imposta alla ricerca e il Fondo NGS, la risposta del Governo del 25 marzo 2026 descriveva procedimenti ancora in corso. Il comunicato MonitoRare del luglio 2026 segnalava persistenza di criticità attuative per alcune misure. Nessuna delle due fonti, da sola, dimostra che ogni iter sia rimasto nella medesima situazione a ottobre. La ricerca effettuata non ha individuato documenti sufficienti per certificare l'intero stato successivo di questi tre percorsi. [7,1]

Per i LEA è disponibile invece un aggiornamento successivo: il Portale istituzionale documenta la pubblicazione dei provvedimenti e la decorrenza differita. La situazione normativa è quindi cambiata rispetto ai rapporti di luglio. L'erogazione regionale effettiva resta un livello separato, che richiede dati su laboratori, sistemi di esenzione e servizi. [8]

La formula metodologica è la seguente: la valutazione distingue costituzione degli organismi, attività documentate, provvedimenti adottati e risultati misurabili per i pazienti. L'assenza nelle fonti consultate di verbali o rendicontazioni complete non dimostra inattività. Le misure attribuite ad AIFA, Ministeri o Regioni non sono imputate al Tavolo o al Comitato senza un collegamento documentale.

Quanto a disclosure e interessi, questo testo nasce da una richiesta di analisi per la Fondazione e cita aziende solo a fini informativi. Non sono stati forniti contratti di sponsorizzazione, finanziamenti o dichiarazioni personali degli autori; non viene quindi affermata l'assenza di rapporti economici non accertati. La scheda di pubblicazione istituzionale deve riportare autori, revisori ed eventuali finanziatori sulla base di informazioni reali.

La proposta operativa è una relazione semestrale pubblica con stato degli atti, avanzamento delle risorse e risultati di accesso. Deve essere possibile distinguere misura non adottata, misura adottata ma non operativa, misura operativa e misura valutata. Queste categorie descrivono fatti differenti e aiutano a formulare richieste istituzionali precise.

19 Continuità assistenziale e famiglie

Una strategia sui farmaci deve considerare la continuità dell'assistenza. Un trattamento può richiedere controlli ripetuti, infusioni, competenze infermieristiche, riabilitazione e adattamenti nella vita familiare. Anche quando modifica il decorso della malattia, può non eliminare i bisogni già presenti. Il beneficio va valutato con il paziente, evitando che l'introduzione del farmaco riduca l'attenzione agli altri servizi.

La mobilità verso un centro esperto può essere appropriata. Diventa una barriera quando il paziente non dispone di trasporto, tempo, assistenza o informazioni. La proposta è registrare il bisogno logistico nel piano assistenziale e prevedere un referente per l'organizzazione. L'aiuto non dovrebbe dipendere esclusivamente dall'iniziativa della famiglia o dalle associazioni.

Il passaggio dall'età pediatrica a quella adulta richiede responsabilità condivise. Occorre identificare il servizio ricevente, trasmettere le informazioni rilevanti e programmare il controllo successivo prima di concludere il percorso precedente. Il trasferimento amministrativo non deve produrre una sospensione di prescrizioni, monitoraggio o supporto. La stessa attenzione serve quando il paziente cambia residenza o struttura di riferimento.

La continuità farmaceutica dovrebbe essere misurata attraverso interruzioni non clinicamente motivate, problemi di rinnovo, disponibilità delle forniture e tempi di risoluzione. Un'interruzione dovuta a una scelta clinica va distinta da una carenza del servizio, così come la decisione informata del paziente va distinta dalla rinuncia per difficoltà economiche o logistiche.

Si propone di raccogliere anche esiti riferiti dal paziente, con strumenti brevi e pertinenti. Dolore, fatica, autonomia, tempo dedicato alle cure e qualità del percorso possono rendere visibili problemi che non emergono dal solo dato di laboratorio. Non occorre misurare tutto per ogni terapia: va selezionato ciò che può orientare una decisione e migliorare l'assistenza.

Il sostegno ai caregiver deve essere collegato ai bisogni e alle misure applicabili, senza presentare come già operativo un fondo il cui percorso non sia accertato. Il centro può facilitare l'orientamento, ma non può sostituire le amministrazioni competenti per prestazioni sociali e previdenziali. La proposta è una presa in carico che renda comprensibili i passaggi e mantenga un punto di contatto quando emergono difficoltà.

20 Dati e misurazione dei risultati

Il sistema di monitoraggio proposto ha un obiettivo preciso: capire dove si interrompe il percorso e se le azioni migliorano accesso ed esiti. Non deve diventare un nuovo obbligo di compilazione che rallenta la cura. Il nucleo informativo dovrebbe riutilizzare dati già disponibili quando affidabili, integrandoli solo per domande che i flussi esistenti non risolvono.

Gli eventi essenziali sono sospetto clinico, invio, prima valutazione, conferma diagnostica, decisione terapeutica, completamento dei requisiti, prima erogazione e controlli successivi. Ogni data deve avere una definizione. Una prenotazione non equivale a una visita; una prescrizione non equivale a una dispensazione; una dispensazione non equivale necessariamente a una somministrazione.

Il denominatore deve includere, quando identificabili, i pazienti eleggibili in attesa. Limitarsi ai trattati può nascondere un problema di accesso. Le motivazioni devono distinguere attesa amministrativa, capacità del centro, disponibilità del prodotto, scelta clinica, preferenza del paziente e informazione mancante. Le categorie devono essere semplici e condivise.

I dati vanno interpretati insieme al contesto. Un territorio può avere tempi maggiori perché concentra casi complessi; un numero ridotto di pazienti può rendere instabili le percentuali. Occorrono aggregazioni appropriate, intervalli di incertezza e cautele nella diffusione delle celle piccole. Non è utile pubblicare classifiche che permettano di identificare persone o che trasformino differenze di casistica in giudizi di qualità.

La governance dei dati dovrebbe definire titolari, responsabilità, accessi, basi giuridiche e tempi di conservazione. Il collegamento tra registri e flussi deve essere valutato per finalità e necessità; la pseudonimizzazione non elimina ogni rischio. Il documento propone il risultato informativo, senza presupporre che un'unica piattaforma nazionale sia già pronta o che ogni integrazione sia consentita automaticamente.

La restituzione ai servizi è essenziale. Un cruscotto dovrebbe produrre liste operative per risolvere casi bloccati e sintesi aggregate per la programmazione. La relazione pubblica dovrebbe mostrare anche dati mancanti e qualità della copertura. Solo così un miglioramento degli indicatori può essere letto come miglioramento del percorso, e non come effetto di una diversa raccolta dei dati.

21 Un programma nazionale per l'accesso effettivo

Il programma proposto dovrebbe essere incorporato nell'attuazione del Piano nazionale e nel successivo ciclo di programmazione. La scelta evita di creare un organismo concorrente e utilizza il coordinamento esistente per rendere verificabili le responsabilità. Il Ministero definirebbe il quadro con le Regioni; il CoNaMR contribuirebbe all'indirizzo e al controllo dell'avanzamento; AIFA manterrebbe le decisioni sui medicinali.

La prima componente è lo standard di percorso. Per ciascun gruppo prioritario devono essere definite le informazioni necessarie, i passaggi e le modalità di invio. L'adozione dovrebbe coinvolgere professionisti e pazienti e distinguere una parte comune nazionale dagli adattamenti organizzativi territoriali.

La seconda componente è il coordinamento dei casi bloccati. Ogni Regione dovrebbe indicare un referente operativo capace di raccordare centro, farmacia e azienda sanitaria. Il referente non dovrebbe rivalutare il prezzo o sostituire il clinico: dovrebbe individuare e risolvere il passaggio amministrativo o logistico non completato.

La terza componente è la capacità. Il piano deve associare alla previsione dei pazienti risorse di personale, laboratorio e somministrazione. Le terapie con requisiti particolari richiedono una verifica della preparazione del centro prima dell'avvio e una programmazione delle attività successive.

La quarta componente è la rendicontazione. Per ogni percorso pilota devono essere misurati tempi, continuità e ragioni di mancato trattamento. Il confronto tra territori dovrebbe essere utilizzato per apprendere e correggere, con attenzione alla comparabilità della casistica.

La quinta componente è l'aggiornamento. Una nuova indicazione, una modifica di sicurezza o una decisione regolatoria devono avere un responsabile per la revisione del percorso. Il sistema non può essere progettato soltanto per l'arrivo del nuovo prodotto: deve gestire estensioni, rivalutazioni e cambiamenti nella disponibilità.

L'adozione richiede una scelta amministrativa concreta. Questo white paper non identifica il programma come già istituito e non impegna le amministrazioni. Propone un perimetro attuabile e una sperimentazione limitata, con valutazione prima dell'estensione. La copertura dovrebbe distinguere costi iniziali, gestione continuativa e costi dei trattamenti, evitando che la raccolta dei dati assorba le risorse necessarie alla cura.

22 Priorità risorse e responsabilità

La selezione dei percorsi pilota dovrebbe partire da una valutazione trasparente. Si propone di attribuire priorità a condizioni con rischio di danno irreversibile, trattamenti con beneficio clinico documentato, difficoltà organizzative riconoscibili e possibilità di misurare il cambiamento. L'equità richiede inoltre di considerare fragilità sociali e distanze dai servizi.

Le risorse non vengono quantificate con un importo nazionale inventato. Prima del finanziamento occorre un preventivo basato su numero di percorsi, fabbisogno professionale e sistemi disponibili. Il piano economico deve distinguere personale, formazione, diagnostica, coordinamento, raccolta dei dati, logistica e trattamento. Un progetto senza queste voci rischia di finanziare la piattaforma e lasciare scoperto il servizio.

Il Ministero dovrebbe promuovere l'accordo sulle definizioni e rendicontare gli atti nazionali. Le Regioni dovrebbero adottare i percorsi, identificare i responsabili e verificare la capacità. Le aziende sanitarie dovrebbero assicurare l'operatività e risolvere gli impedimenti di competenza. I centri dovrebbero documentare decisioni cliniche, attese e risultati, con un carico proporzionato.

AIFA dovrebbe contribuire alla leggibilità dei percorsi regolatori, alla verifica delle condizioni di accesso e alle informazioni sui medicinali di propria competenza. ISS dovrebbe sostenere qualità epidemiologica e coerenza dei dati. Il coinvolgimento di AGENAS dovrebbe essere definito nell'ambito delle sue attribuzioni, per aspetti organizzativi e valutazione dei servizi, senza sovrapporre le competenze sui medicinali.

Le imprese dovrebbero fornire informazioni affidabili su fabbisogno produttivo, disponibilità e prove da generare. Le associazioni dovrebbero partecipare alla definizione dei bisogni e alla valutazione dell'esperienza di cura, con modalità trasparenti e capacità di rappresentare anche situazioni meno visibili. La partecipazione non deve trasferire ai pazienti il compito di far funzionare il percorso.

Il principio di responsabilità è semplice: a ogni attività devono corrispondere un titolare e un risultato verificabile. I soggetti consultati non diventano automaticamente responsabili della decisione. Una matrice chiara riduce il rischio che tutti siano coinvolti e nessuno sia identificabile quando il paziente resta in attesa. I conflitti tra competenze devono essere risolti nel protocollo, prima che emergano nel singolo caso.

23 Roadmap proposta per dodici mesi

Nei primi novanta giorni si propone di costituire un gruppo operativo dentro la governance esistente, selezionare i percorsi pilota e definire le informazioni minime. Il gruppo dovrebbe produrre un mandato, un elenco delle responsabilità, un preventivo e criteri di valutazione. Il prodotto della fase è un piano attuativo approvabile, non una nuova dichiarazione generale di intenti.

Tra il quarto e il sesto mese, i territori partecipanti dovrebbero avviare la misurazione e verificare i punti di interruzione. I centri dovrebbero ricevere istruzioni semplici e assistenza tecnica. La fase deve consentire di distinguere dati non raccolti e problemi reali, prima di formulare confronti tra Regioni.

Tra il settimo e il nono mese, il programma dovrebbe introdurre correzioni mirate: eliminazione di richieste duplicate, raccordo tra laboratorio e centro, definizione dei contatti per i casi urgenti e programmazione delle forniture. Ogni modifica deve avere una motivazione e una data, in modo da poter collegare il cambiamento del servizio a quello degli indicatori.

Tra il decimo e il dodicesimo mese, la valutazione dovrebbe confrontare risultati e situazione iniziale, considerando composizione dei pazienti e qualità dei dati. Dove possibile, è opportuno utilizzare territori o periodi di confronto, senza presentare una semplice variazione prima–dopo come prova definitiva di causalità.

La relazione finale dovrebbe indicare quali interventi hanno funzionato, quali non hanno prodotto risultati e quali richiedono risorse aggiuntive. L'estensione nazionale dovrebbe essere una decisione successiva, basata sulla valutazione e sulla sostenibilità. I percorsi con risultati incerti dovrebbero essere modificati prima dell'ampliamento.

Le scadenze sono una proposta operativa di questo documento. Non sostituiscono i tempi di legge o le urgenze cliniche. Un paziente con una necessità immediata non deve attendere la conclusione del progetto pilota: il percorso ordinario e i canali applicabili restano attivi.

Si suggerisce una pubblicazione trimestrale dell'avanzamento dei piloti e una relazione semestrale sulla governance nazionale. Il calendario dovrebbe includere la preparazione della programmazione successiva al Piano 2023–2026, con una verifica dell'attuazione precedente. L'obiettivo è rendere cumulativo il lavoro: ogni ciclo deve partire da ciò che è stato realmente realizzato e da ciò che resta da completare.

24 Indicatori e criteri di successo

Il programma deve distinguere indicatori di attività e di risultato. Il numero di riunioni, centri coinvolti o persone formate descrive il lavoro svolto. Il tempo necessario a una diagnosi utile, la continuità del trattamento e il beneficio clinico descrivono ciò che cambia per il paziente. Entrambi sono rilevanti, ma non possono sostituirsi.

Per i tempi si propone di pubblicare mediana e distribuzione, non soltanto media. Il novantesimo percentile può rendere visibili le attese più lunghe, ma va utilizzato solo con numerosità adeguate. Devono essere presenti i casi ancora aperti e le motivazioni delle sospensioni. Un target organizzativo non deve incentivare la chiusura formale dei casi senza soluzione.

Per l'equità si propone di osservare differenze per territorio di residenza, età, distanza dal centro e condizioni di vulnerabilità quando le informazioni sono raccolte lecitamente. La mobilità non è automaticamente un insuccesso: può esprimere un invio appropriato. Il criterio è capire se il paziente ha ottenuto la prestazione e con quale onere.

Per la continuità si propone di registrare interruzioni amministrative, rinnovi in ritardo e mancati controlli dovuti al servizio. Gli esiti clinici vanno scelti per patologia e terapia, con indicazione del periodo osservato. Non è possibile costruire un unico punteggio di efficacia valido per tutte le malattie rare.

Gli obiettivi quantitativi dovrebbero essere stabiliti dopo la misurazione iniziale. Prima della baseline si possono fissare impegni di processo: tutti i percorsi pilota con responsabile identificato, definizioni approvate e rendicontazione della qualità dei dati. Non si propone una percentuale nazionale di riduzione dei tempi come se fosse già validata.

Il successo richiede anche verifica degli effetti indesiderati. Una riduzione del tempo alla prima dose può essere accompagnata da sovraccarico dei centri o peggioramento dei controlli. Un sistema di accesso rapido deve quindi misurare sicurezza, completezza delle valutazioni e continuità insieme alla velocità.

La valutazione dovrebbe essere affidata a competenze capaci di distinguere dati, interpretazioni e interessi. I risultati devono essere pubblicati anche quando non favorevoli, con limiti e interventi correttivi. Questo renderebbe il programma uno strumento di apprendimento e responsabilità, invece di una rendicontazione costruita soltanto sui risultati positivi.

25 Matrice delle criticità e delle soluzioni

La matrice seguente riassume le proposte. Non certifica che ogni criticità abbia la stessa intensità in tutti i territori. Per ciascun intervento, l'amministrazione competente dovrebbe verificare il bisogno, adottare l'atto necessario e definire la copertura. Gli indicatori sono suggerimenti da validare nei percorsi pilota.

Criticità	Intervento proposto	Responsabile principale	Misura verificabile
Diagnosi dispersa	Criteri di invio e consulto esperto	Regioni e centri	Tempo dal sospetto alla valutazione
Test senza percorso	Finanziare interpretazione e restituzione	Regioni e laboratori	Referti con consulenza e decisione successiva
Attese non spiegate	Separare fasi e motivazioni	AIFA e Regioni	Distribuzione dei tempi e casi aperti
Attivazione territoriale lenta	Protocollo con compiti nominativi	Regioni e aziende sanitarie	Tempo alla prima erogazione
Capacità insufficiente	Piano di personale e appuntamenti	Aziende sanitarie	Attese e rinvii per capacità
Forniture discontinue	Previsione e piano di continuità	Aziende sanitarie e fornitori	Interruzioni evitabili e durata
Incertezza sugli esiti	Piano di evidenze e rivalutazione	AIFA centri e titolari	Follow-up ed esiti previsti
Mobilità onerosa	Raccordo con il territorio e supporto logistico	Regioni e centri	Rinunce e oneri riferiti dai pazienti
Attuazione poco leggibile	Registro pubblico delle decisioni	Ministero e amministrazioni competenti	Misure adottate operative e valutate

Il criterio trasversale è la proporzionalità. L'innovazione deve raggiungere i pazienti appropriati con un percorso sicuro, mentre gli obblighi amministrativi devono essere commisurati al rischio e all'utilità del dato. Una nuova procedura è giustificata quando risolve un problema identificato; deve essere rivista quando genera un ostacolo senza migliorare la decisione.

L'indirizzo conclusivo del white paper è rendere misurabile l'accesso effettivo. La disponibilità di medicinali, le competenze della rete e il quadro legislativo sono una base su cui costruire. Il prossimo passaggio è collegare questi elementi a responsabilità operative, risorse e risultati verificabili per le persone. La credibilità delle proposte dipenderà dalla capacità di descrivere sia i progressi sia gli aspetti ancora non accertati.

Fonti e riferimenti

Riferimenti numerati richiamati nel testo. Consultazione documentale al 7 ottobre 2026. Le note distinguono contenuti letti integralmente da informazioni istituzionali recuperate tramite indicizzazione. I limiti di accesso sono dichiarati per evitare una precisione documentale non dimostrata.

[1] UNIAMO. Presentazione del XII Rapporto MonitoRare. 2 luglio 2026. Apri la fonte
Disponibilità dei medicinali, rete e attuazione; dati con anni di riferimento distinti.

[2] ISS. Rapporto ISTISAN 25/22 sul Registro nazionale malattie rare. 19 gennaio 2026; biennio 2022–2023. Apri la fonte
Scheda bibliografica istituzionale; lettura integrale impedita da limitazione tecnica.

[3] EMA. Orphan designation overview. Pagina istituzionale consultata il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Criteri della designazione orfana e distinzione dall'autorizzazione.

[4] Gazzetta Ufficiale. Legge 175/2021 articolo 5. 27 novembre 2021. Apri la fonte
Assistenza farmaceutica e disponibilità nelle more degli aggiornamenti dei prontuari.

[5] Ministero della Salute. Istituito il Tavolo tecnico in tema di malattie rare. 21 giugno 2021. Apri la fonte
Annuncio istitutivo individuato; pagina integrale bloccata dal sistema del sito.

[6] Gazzetta Ufficiale. Legge 175/2021 articolo 8. 27 novembre 2021. Apri la fonte
Composizione e funzioni del Comitato nazionale per le malattie rare.

[7] Camera dei Deputati. Risposta all'interrogazione 5-05184 Malavasi. 25 marzo 2026. Apri la fonte
Allegato relativo all'attuazione della normativa; stato documentato a marzo.

[8] Ministero della Salute e ISS. Nuovi LEA più spazio alla diagnosi precoce e alle esenzioni. 2 ottobre 2026. Apri la fonte
Pubblicazione dei provvedimenti, novità e decorrenza differita.

[9] AIFA. Graduatoria del bando di ricerca indipendente sulle malattie rare. 15 giugno 2026. Apri la fonte
Diciannove progetti e importo ammesso; determina 816/2026.

[10] EMA. Kaftrio EPAR. Consultato il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Risultati degli studi, indicazione e titolare dell'autorizzazione.

[11] AIFA. Determina PRES/168/2026 Kaftrio. 2026; avviso in GU del 18 febbraio. Apri la fonte
Estensione rimborsata, prescrizione e chiusura dei registri precedenti.

[12] AIFA. Chiusura registri Kaftrio. 19 febbraio 2026. Apri la fonte
Comunicazione operativa della chiusura del monitoraggio.

[13] EMA. Zolgensma EPAR e sintesi del medicinale. Consultati il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Studio su ventidue bambini; sintesi dei risultati verificata tramite recupero indicizzato.

[14] AIFA. Registro Zolgensma aggiornato. 18 marzo 2024; aggiornamento 19 marzo. Apri la fonte
Perimetro rimborsato ed eleggibilità; comunicazione relativa alla determina 46/2024.

[15] AIFA. Rapporto sulle tempistiche di prezzo e rimborso 2024–2026. Luglio 2026. Apri la fonte
Sintesi istituzionale dei tempi medi; contenuto recuperato dall'indice della fonte.

[16] Marino ML e collaboratori. Farmaci orfani in Italia disponibilità e tempi di accesso a livello regionale. Global & Regional HTA 2023;10:89–97; DOI 10.33393/grhta.2023.2641. Apri la fonte
Studio originale; dati storici 2016–2021 e definizione della prima movimentazione.

[17] AIFA. Accesso precoce e uso off label. Consultato il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Distinzione tra legge 648/1996, Fondo nazionale AIFA e uso compassionevole.

[18] AIFA. Farmaci a uso compassionevole. Consultato il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Fornitura gratuita e parere del comitato etico; contenuto istituzionale indicizzato.

[19] EMA. Strensiq EPAR e sintesi del medicinale. Consultati il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Studio pediatrico e valutazione radiografica; contenuto recuperato dalla fonte indicizzata.

[20] AIFA. Attivazione registro Strensiq. 28 gennaio 2025. Apri la fonte
Indicazione rimborsata e schede di eleggibilità; determina 28/2025.

[21] EMA. Translarna EPAR e decisione di non rinnovo. Decisione della Commissione del 28 marzo 2025. Apri la fonte
Stato regolatorio e mancata conferma dell'efficacia; aggiornamento istituzionale indicizzato.

[22] UNIAMO. Executive summary MonitoRare 2026. Luglio 2026. Apri la fonte
Spesa 2024, registri, mobilità e rinnovo del Comitato; le criticità sono riferite alla data del rapporto.

[23] Conferenza Stato Regioni. Accordo repertorio 121/CSR. 24 maggio 2023. Apri la fonte
Piano 2023–2026 e riordino rete; atto individuato, apertura integrale non completata.

[24] Ministero della Salute. Carta di Roma al primo Summit nazionale sulle malattie rare. 16 giugno 2026. Apri la fonte
Pubblicazione del documento di indirizzo; lettura integrale della pagina impedita dal sito.

[25] Commissione europea. Overview del regolamento HTA. Consultato il 7 ottobre 2026. Apri la fonte
Valutazione clinica congiunta e applicazione dal gennaio 2025.

[26] Commissione europea. Presentazione sull'attuazione del regolamento HTA. 22 novembre 2023. Apri la fonte
Fasi del calendario: terapie avanzate, medicinali orfani dal 2028 e pieno perimetro dal 2030.